

Valores de referencia Nefrología

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Proteinuria

Falsos positivos: pH alcalino, hematuria macroscópica

+: 30 - 99 mg/dl

++: 100 – 299 mg/dl

+++: 300 – 999 mg/dl

++: > 1000 mg/dl

Orina de 24hs (N): < 4mg/m²/h ó 5mg/Kg/día

Índice proteinuria/creatinuria en primera orina de la mañana patológica: > 0,2

Cilindros

Hialinos: mucoproteínas de Tamm-Horsfall solas

No patológico en procesos febriles, deshidratación o ejercicio.

Granulosos: mucoproteínas más células degeneradas: inespecíficos, en general patológicos (deshidratación, posejercicio, NTA, acidosis tubular renal, glomerulonefritis)

Leucocitarios: inflamación renal: típicos en PNA.

Glanulosos y céreos: sugiere IRA.

Hemáticos: indica sangrado intraparenquimatoso, típicos del síndrome nefrítico, pueden aparecer postejercicio y por traumatismo.

Cilindros de células tubulares: puede aparecer en cuadros de deshidratación, en S° nefrítico o procesos tubulointericiales.

Análisis bioquímico

Na/creatinuria (mg/mg): >2 años: 0.20 +/- 0,07

Ca/creatinuria: > 1 a: 0,14 +/- 0,06

0-6m: 0,80

7-12m: 0,60

Ac. Úrico/creatinuria: 3-4a: 0,88 +/- 0,22

5-6a: 0,71 +/- 0,21

7-8a: 0,62 +/- 0,18

9-10a: 0,56 +/- 0,16

11-12a: 0,48 +/- 0,13

13-14a: 0,39 +/- 0,11

En orina de 24hs

Na: 3,78 +/- 1,3 mEq/Kg/día

Ante un sodio corporal total bajo (hipovolemia), la respuesta renal normal es aumentar la reabsorción de sodio, por lo que se espera tener un sodio urinario < 20 mEq/L; si se obtiene un sodio urinario > **20 mEq/L**, es probable que la pérdida de líquidos sea de causa renal. (S° de Secreción inadecuada de ADH, donde el paciente tendrá oliguria o S° perdedor de sal, donde habrá una poliuria)

K: 1,73 +/- 0,7

Cl: 3,98 +/- 1,4

Ca: 2,38 +/- 0,7 (hipercalcemia: >4)

Ácido úrico: 520 +/- 147 mg/día/1,73 m²

Fosfato: 12,4 +/- 4,6 mg/kg/día

Oxalato: 36,9 +/- 13,7 mg/día/1,73 m²

Citrato: 9,62 +/- 4,05 mg/día/1,73 m²

Clearence o depuración (medición del filtrado glomerular)

Fórmula utilizada por el laboratorio: $\frac{\text{Creatinuria (mg/dl)}}{\text{Creatinemia (mg/dl)}} \times \text{Volumen urinario (ml/min)}$

Para resultados más precisos se puede corregir los valores con respecto a la superficie corporal media del adulto (1,73 m²)

$\frac{\text{Creatinuria}}{\text{Creatinemia}} \times \text{Volumen urinario (ml/min)} \times \frac{1,73}{\text{Sup. Corporal}}$
--

Fórmula de Schwartz = K x talla (cm) / Pcr(mg/dl) (K: < 1 año: 0,45 - > 1 año: 0,55)

Valores normales

Prematuro: 29 a 65

RN: 26 a 60

3m: 30 a 86

6m: 41 a 105

12m: 49 a 157

Segundo año: 63 a 191

Valores aumentados indican disminución de la filtración glomerular.
--